



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І
«ФАРМАЦІЯ» ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

ID здобувача / Student ID							
3	4	1	1	1	6	3	8

Прізвище / Surname									
В	Е	С	І	Л	О	В	С	Г	А

Варіант / Variant 45

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ
СКЛАДАННЯ ЛЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОВОГО
ІСПИТУ**

КРОК 3

**Спеціальність
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ»**

1. У доношної дитини на 4-ту добу життя на шкірі різних ділянок спостерігаються: еритема, множинні ерозії та тріщини, ділянки відшарування епідермісу. Зовнішній вигляд нагадує опік від окропу. Симптом Нікольського позитивний. Який найімовірніший діагноз?

- A. Імпетиго
- B. Ексофоліативний дерматит Ріттера
- C. Везикулопустульоз
- D. Бульозний епідермоліз
- E. Справжня екзема

2. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на появу світлих плям на шиї, які помітила після засмагання на морі, плями суб'єктивно не турбують. Із анамнезу відомо, що два місяці тому перенесла стрес, розлучена. Об'єктивно спостерігається: на шкірі задньої та бокових поверхонь шиї — множинні округлі гіпопигментні плями різного розміру у вигляді мережива, лущення відсутнє. Під час огляду ротової порожнини — на піднебінні та губах є дисеміновані лентікулярні округлі папули мідно-червоного кольору з ерозованою поверхнею. Визначається помірний поліаденіт. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний плоский лишай
- B. Лепра, туберкулоїдна форма
- C. Червоний вовчак дисемінований
- D. Сифіліс вторинний рецидивний
- E. Сифіліс вторинний свіжий

3. У семирічної дитини після перенесеної коронавірусної хвороби на шкірі гомілок з'явилися численні дрібні висипи у вигляді крововиливів діаметром 1-2 мм, які під час діаскопії не зникають. Яким первинним морфологічним елементом представлений висип на шкірі?

- A. Розеолю
- B. Вібіцес
- C. Екхімозом
- D. Петехією
- E. Пурпурою

4. Пацієнту віком 25 років із пневмонією призначено введення цефтріаксону в/в. Через 10 хв після ін'єкції пацієнт скаржиться на напад задишки, стиснення за грудниною, посилення кашлю, захриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: набряк шиї та обличчя, АТ — 85/40 мм рт. ст., ЧСС — 120/хв. Аускультативно в легенях вислуховується велика кількість свистячих та дзижчачих хрипів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Напад астми
- B. Набряк легень
- C. Пневмоторакс
- D. Анафілактичний шок
- E. Ортостатичний колапс

5. У пацієнта віком 35 років, який перебуває на обліку у лікаря-дерматовенеролога з приводу псоріазу, з'явилися свіжі елементи висипу у вигляді міліарних і лентікулярних рожево-червоних папул зі сріблястобілими лусочками у місцях травмування шкіри — на ділянках розчухів, царапини кота, на животі по ходу ремня тощо. Для якого феномена/симптому є характерними виявлені у пацієнта клінічні прояви?

- A. Симптому Картамішева
- B. Феномена Кебнера
- C. Феномена Уікхема
- D. Феномена Полотебнова
- E. Симптому Ядасона

6. У пацієнта віком 34 роки зі встановленим діагнозом: вторинний рецидивний сифіліс — у першу добу пеніцилінотерапії в шкірно-венерологічному диспансері розвинулася реакція Лукашевича-Яриша-Герксгеймера. Якою має бути лікарська тактика в цьому разі?

- A. Вести в/в теофілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- B. Замінити пеніцилін на інший антибіотик
- C. Ввести пацієнту розчин атропіну
- D. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта
- E. Спостерігати за станом пацієнта

7. Пацієнт віком 39 років, у якого діагностовано тиреотоксикоз, скаржиться на зміну нігтів пальців рук. Об'єктивно спостерігається: нігтьові пластинки пальців рук, переважно вказівного та середнього пальців, мають ложкоподібну (увігнуту) форму, потовщені й більш м'які за інші нігтьові пластинки, водночас без зміни їх кольору та гладкості. Для якого типу оніходистрофії характерні виявлені у пацієнта зміни нігтів?

- A. Оніхошизису
- B. Койлоніхії
- C. Оніхолізису
- D. Ганалоніхії
- E. Оніхореक्सису

8. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на значні слизово-гнійні виділення зі статевих шляхів, свербіж, печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, біль під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкірних покривів і слизових оболонок зовнішніх статевих органів, внутрішньої частини стегон і перианальної ділянки. Із анамнезу відомо, що мати дитини хворіє на гонорею. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гonoкоковий вульвовагініт
- B. Бактеріальний вагіноз
- C. Урогенітальний трихомоніаз
- D. Уреаплазмозний вагініт
- E. Кандидозний вульвовагініт

9. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу утворень у ділянці статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: на шкірі геніталій наявні сосочкоподібні утворення, що мають ніжку та нагадують кольорову капусту, їхня консистенція м'яка, не болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вульгарні бородавки
- B. Плоскоклітинний рак
- C. Гострий кандидоз
- ☒ D. Папіломавірусна інфекція
- E. Сифілітичні широкі кондиломи

10. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкіри з визначенням та розробкою тактики лікування, динамічного спостереження, та реабілітації пацієнта, хворого на атопічний дерматит. За якою шкалою оцінюється тяжкість атопічного дерматиту?

- ☒ A. SCORAD
- B. DLOI
- C. PGA
- D. BSA
- E. PASI

11. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на появу висипу в ділянці лівої молочної залози, дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що впродовж 2-х років жінка періодично лікувалася з приводу екземи соска. Ефект був нестійким та невиразним, захворювання поступово прогресувало. Об'єктивно спостерігається: ареола та частково шкіра лівої молочної залози ерозовані, яскраво-червоного кольору, межі вогнища ураження фестончасті, чіткі, місцями валкоподібні. Лівий сосок виглядає як дещо сплюснений, частково втягнений. Пахвові лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, невеличкі, рухомі. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ A. Хвороба Педжета
- B. Хвороба Боуена
- C. Спіноцелюлярний рак шкіри
- D. Хвороба Реклінгаузена
- E. Базальноклітинний рак шкіри (базаліома)

12. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на висипи на верхній губі, яким передувало загальне нездужання. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці верхньої губи на еритематозно-набряковому тлі є згруповані везикули від 2 до 4 мм у діаметрі із серозним вмістом. Рецидиви захворювання відбуваються 4-5 разів на рік. Які системні препарати є першою лінією терапії в цій ситуації?

- A. Індуктори інтерферонів
- B. Ациклічні аналоги нуклеозидів
- C. Кортикостероїди
- D. Імуноглобуліни
- ☒ E. Інтерферони

13. Пацієнт віком 28 років скаржиться на появу після незначної гарячки пухирців на шкірі обличчя та слизовій оболонці рота. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці губ, крилах носа та слизовій оболонці рота ліворуч візуалізуються міхурці діаметром до 2 мм, згруповані по 3-5 міхурців із прозорим та мутним вмістом, ерозії яскраво-червоного кольору з поліциклічними обрисами. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пухирчатка еритематозна
- B. Стрептококове імпетиги
- C. Стафілококове імпетиги
- D. Дерматит герпетичформний
- ☒ E. Герпес простий

14. Які з рідкісних захворювань призводять до скорочення тривалості життя пацієнтів або їх інвалідизації?

- A. Дерматит Дюринга
- ☒ B. Бульозний епідермоліз
- C. Мікробна екзема
- D. Вульгарний псоріаз
- E. Порокератоз

15. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипань на шкірі внутрішньої поверхні передпліч, променевозап'ястних та гомілковостопних суглобів. Об'єктивно спостерігається: монотипний висип у вигляді лентикулярних запальних, блискучих, полігональних папул, на поверхні яких опалоподібні білі або сіруваті смужки. У центрі деяких папул є пупкоподібні вдавлення. Який найімовірніший діагноз?

- A. Токсикодермія
- B. Атопічний дерматит
- C. Псоріаз
- D. Контагіозний моллюск
- ☒ E. Червоний плоский лишай

16. У восьмирічної дівчинки на волосистій частині голови виявлено одиничне вогнище діаметром 3 см обляманого волосся на рівні 5-7 мм над шкірою, «муфтами» та лущенням в основі фолікулів. За результатами мікроскопії встановлено діагноз: мікоз волосистої частини голови. Яке передбачуване джерело інфікування?

- A. Худоба
- ☒ B. Кішка
- C. Грунт
- D. Забруднені водойми
- E. Миші

17. Пацієнтка віком 39 років звернулася зі скаргами на масивне випадіння волосся по всій поверхні скальпа. З анамнезу відомо,

що 3 місяці тому перенесла коронавірусну інфекцію (підтвердження позитивним тестом ПЛР), перебувала у стаціонарі через прояви дихальної недостатності, гарячки. Об'єктивно спостерігається: дифузне порідіння волосся, явища атрофії або рубцювання відсутні. Трихоскопічно: вертикально відростаюче волосся, переважання одиничних фолікулярних юнітів, жовті точки, стоншене термінальне волосся. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гніздова алопеція
- В. Фронтальна фіброзуюча алопеція
- С. Трихотилomanія
- Д. Телогенова алопеція
- Е. Себореїний дерматит

18. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задихань, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ — 110/60 мм рт. ст., ЧСС — 40/хв. Яка речовина, ймовірно, викликала отруєння?

- А. Азот
- В. Сірководень
- С. Аміак
- Д. Хлор
- Е. ФОС

19. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на відчуття дискомфорту, збільшення розмірів губ, язика. Із анамнезу відомо, що 10 хв тому пацієнтку вкусила бджола. Об'єктивно спостерігається: набряклі губи та шия, язик ледве вміщається в роті. Набряклі ділянки напружені, неbolючі під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- А. Симпато-адреналова криза
- В. Гостра кропив'янка
- С. Набряк Квінке
- Д. Напад бронхіальної астми
- Е. Анафілактичний шок

20. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на висип у межах голівки статевого члена. Свербіж, больові відчуття заперечує. З анамнезу відомо, що 2 роки тому мав анафілактичний шок після ін'єкції пеніциліну. Останній рік веде незахищене статеве життя з різними партнерами. Об'єктивно спостерігається: на голівці статевого члена ерозія 0,2x0,3 см на незапальному тлі, щільна у основі під час пальпації. З правого боку збільшені пахові лімфатичні вузли. Серологічна діагностика: РПГА на *Treponema pallidum* — позитивна, РПР — позитивна. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту в цьому разі?

- А. Пеніцилін
- В. Преднізолон
- С. Доксидиклін
- Д. Метронідазол
- Е. Ацикловір

21. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на свербіж у ділянці уретри, біль під час сечовипускання, невелику кількість жовто-зелених виділень. За результатами мікроскопії мазка виявлено: грамнегативні дрібні кокоподібні мікроорганізми. Який збудник, найімовірніше, викликав захворювання?

- А. *Chlamydia trachomatis*
- В. *Trichomonas vaginalis*
- С. *Candida albicans*
- Д. *Neisseria gonorrhoeae*
- Е. —

22. У пацієнта віком 24 роки під час огляду виявлено: на шкірі тулуба спостерігаються три круглі плями білого кольору з чіткими межами, по краю одного з вогнищ візуалізується гіперпигментація, в уражених ділянках — волосся білого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- А. Вітіліго
- В. Туберозний склероз
- С. Сифілітична лейкодерма
- Д. Різнокольоровий лишай
- Е. Стрептодермія

23. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на збільшення мигдалика в роті та утруднене ковтання впродовж 3-х тижнів. Із анамнезу відомо, що півтора місяця тому мала випадковий ороентальний контакт з незнайомим хлопцем та переохолодження під час вечірньої прогулянки. Об'єктивно спостерігається: загальний стан пацієнтки задовільний, під час огляду — лівий мигдалик збільшений, без ознак запалення, ерозій чи виразки, під час пальпації — щільний. Підщелепні лімфатичні вузли ліворуч збільшені, ущільнені, безболісні та рухомі під час пальпації, шкіра над ними без змін. Який метод діагностики необхідно застосувати першочергово для уточнення діагнозу?

- А. Обстеження на туберкульозну інфекцію
- В. Бактеріологічне дослідження зі слизової мигдалика на піогенну флору
- С. Дослідження пунктату мигдалика на атипові клітини
- Д. Серологічне дослідження на сифіліс
- Е. Бактеріологічне дослідження зі слизової мигдалика на гонорею

24. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу гнійних виділень із уретри, різкий біль на початку сечовипускання. Із анамнезу відомо, що 4 дні тому мав незахищений статевий контакт. Об'єктивно спостерігається: гіперемовані, набряклі губки уретри,

рясні гнійні виділення з уретри. За результатом проведення двохстаканної проби: сеча у першій порції каламутна. Яке дослідження із нижченаведених допоможе встановити потенційний збудник?

- A. Мікроскопічне дослідження: фарбування за Грамом
- B. Огляд під лампою Вуда
- C. Зішкріб на *Demodex folliculorum*
- D. Посів на поживне середовище Сабуро
- E. Дерматоскопія

25. Пацієнт віком 27 років під час проходження військово-лікарської комісії отримав статус «придатний». Згідно зі Змінами до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, з яким діагнозом пацієнт вважається придатним до військової служби?

- A. Дифузний атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією
- B. Герпетичний дерматит
- C. Псоріатична еритродермія
- D. Пухирчатка звичайна
- E. Вітиліго

26. Пацієнт віком 18 років, спортсмен, звернувся зі скаргами на появу висипу на шкірі спини. Дерматологічний та алергологічний анамнез не обтяжені. 2 тижні тому був на змаганнях. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спини множинні дисеміновані плями рожево-коричневого кольору до 0,5 см в діаметрі з чітким фестончастими межами. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено елементи грибів. Який симптом є позитивним при цьому захворюванні?

- A. Нікольського
- B. «Медових стільників»
- C. Сесарі
- D. Дар'є-Унни
- E. Стружки

27. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на появу помірного свербіжу в ділянці плям на шкірі пахвових складок, які присутні більше двох років, проте раніше не турбували. Об'єктивно спостерігається: гіперстенічна тілобудова, в ділянці пахвових складок — гіперпігментні суцільні плями з чіткими округлими межами та з проявами гіперемії. За результатами люмінесцентного дослідження із застосуванням лампи Вуда виявлено: коралово-червоне світіння уражених ділянок шкіри. Для якого захворювання шкіри характерні такі прояви?

- A. Попрілості
- B. Еритразми
- C. Рубромікозу великих складок
- D. Лишаю різнокольорового
- E. Дерматиту алергічного

28. У шестимісячної дитини з'явився висип

на обличчі, що супроводжується свербіжем. Із анамнезу відомо, що дитина захворіла 3 тижні тому після введення прикорму. Об'єктивно спостерігається: на шкірі щік еритема, набряк, дрібні везикули, мокнуття, серозні кірочки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Токсикодермія
- B. Дитяча екзема
- C. Алергічний контактний дерматит
- D. Мікробна екзема
- E. Імпетиг

29. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на відчуття печіння у ділянці підборіддя та щік. Об'єктивно спостерігається: у ділянці щік і підборіддя візуалізуються нечисленні папули та пустули на тлі яскравої гіперемії, шкіра в цих місцях чутлива. Який найімовірніший діагноз?

- A. Розацеа
- B. Червоний вовчак
- C. Акне
- D. Пероральний дерматит
- E. Себорейний дерматит

30. Жінка віком 31 рік звернулася до лікаря через 10 днів після статевого контакту зі скаргами на виділення із піхви, що мають запах «тухлої риби». Який найімовірніший діагноз?

- A. Гарднереллез
- B. Мікоплазмоз
- C. Хламідіоз
- D. Гонорея
- E. Трихомоніаз

31. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на появу через 2 тижні після перенесеного гострого тонзиліту одиничної плями, а через тиждень — поширеного висипу на шкірі, який суб'єктивно її не турбує. Об'єктивно спостерігається: на шкірі живота візуалізуються запальна бляшка рожево-червоного кольору округлої форм діаметром 3 см з чіткими межами з незначним лущенням по периферії, а також рясний дрібний (до 1,5 см) плямистий висип округлої та овальної форми блідо-червоного кольору з чіткими межами, розташований симетрично на тулубі і верхніх кінцівках по лініях Лангера. У центрі плям — лущення у вигляді «цигаркового паперу». Який найімовірніший діагноз?

- A. Мікроспорія гладкої шкіри багатоговищова
- B. Парапсоріаз краплеподібний
- C. Пітиріаз рожевий (Жибера)
- D. Сифіліс вторинний свіжий
- E. Лишай висівкоподібний (різнокольоровий)

32. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу висипу та свербіж у ділянці кистей.

Із анамнезу відомо, що працює малярем. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей і пальців яскраво-рожевого кольору, трохи набрякла, вогнища запальних плям мають схильністю до периферійного росту і злиття, без чітких меж. Свербіж у ділянці висипу посилюється в разі контакту з водою. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Простий контактний дерматит
- ☐ В. Алергічний контактний дерматит
- ☐ С. Короста
- ☐ D. Пітиріаз рожевий (Жибера)
- ☐ E. Червоний плоский лишай

33. Пацієнт віком 46 років, будівельник, скаржиться на появу протягом останніх 6-ти місяців новоутворення на шкірі чола, що періодично кровоточить. Об'єктивно спостерігається: папула із перламутрово-білою поверхнею, судинами в центральній частині та геморагічною кіркою. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Псоріаз
- ☐ В. Саркома Капоші
- ☐ С. Себорейна кератома
- ☐ D. Контагіозний моллюск
- ☐ E. Базальноклітинний рак шкіри

34. Пацієнт віком 28 років скаржиться на висип та випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: дрібновогнищева алопеція волосистої частини голови, численні рожеваті папульозні висипи на долонях та підшвах. Суб'єктивні відчуття в ділянці висипів відсутні. Пахові, пахвові та підщелевні лімфовузли дещо збільшені, неболючі, мають щільно-еластичну консистенцію, рухливі. Загальний стан — без змін. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Пітиріаз рожевий (Жибера)
- ☐ В. Андрогенна алопеція
- ☐ С. Трихофітія
- ☐ D. Псоріаз
- ☐ E. Сифілітична алопеція, долоне-підшвовий папульозний сифілід

35. Які препарати для зовнішнього застосування призначають для лікування корости?

- ☐ А. Мазь кетоконазол
- ☐ В. Емульсію бензілбензоату 20%
- ☐ С. Спиртовий розчин йоду
- ☐ D. Цинкову пасту
- ☐ E. Мазь клобетазол

36. Пацієнтка віком 33 роки, що хворіє на кропив'янку, не має стабільної клінічної відповіді після прийому стандартної дози антигістамінного засобу 2-го покоління. Який наступний терапевтичний крок має бути зроблено в цьому разі?

- ☐ А. Призначення циклоспору
- ☐ В. Призначення 4-кратної дози антигістамінного засобу 1-го покоління
- ☐ С. Призначення омалізумабу
- ☐ D. Призначення 4-кратної дози антигістамінного засобу 2-го покоління
- ☐ E. Призначення 2-кратної дози антигістамінного засобу 2-го покоління та системні кортикостероїди 0,5 мг/кг

37. Пацієнт віком 67 років, який працює листоношею, звернувся зі скаргами на появу вогнища ураження на шкірі чола, яке вперше помітив півроку тому. Свербіж, больові відчуття відсутні, але турбує збільшення розмірів та поява лусочок в межах вогнища ураження. Об'єктивно спостерігається: на шкірі чола візуалізується папула рожевого кольору із білими лусочками на поверхні. Дерматоскопічно: на еритематозному тлі наявні збільшені гіперкератотичні фолікулярні отвори, патери «полунічних зерен». Навколо основного елемента — розширені судини за рахунок фотопошкодження. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Базальноклітинний рак шкіри
- ☐ В. Актинічний кератоз
- ☐ С. Лентиго
- ☐ D. Себорейна кератома
- ☐ E. Кератоакантома

38. Під час роботи медико-соціальної експертної комісії лікар-дерматолог виявив у пацієнта віком 59 років прогресуючий перебіг псоріазу з ураженням висипаннями понад 70% шкіри, гострий псоріатичний артрит колінних і ліктьових суглобів. Пацієнт безперервно перебуває на лікарняному впродовж 10-ти місяців. Встановлено зниження працездатності до 30% (протягом 5-ти місяців вважається непрацездатним). Яка група інвалідності може бути надана пацієнтові?

- ☐ А. 2 група
- ☐ В. 1 група
- ☐ С. Вважається працездатним
- ☐ D. Тимчасова непрацездатність
- ☐ E. 3 група

39. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на появу висипу на шкірі обличчя. З анамнезу відомо, що протягом 2-х останніх років проживала в Єгипті, працювала аніматором на відкритому повітрі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі носа та щік візуалізуються еритематозні пляшки з лущенням на поверхні та тенденцією до формування атрофії в центрі. Лусочки щільно прилягають до вогнища ураження. Загальний стан задовільний. Який із нижченаведених симптомів супроводжує цей дерматоз?

- A.** Бензе-Мещерського
- B.** «Колоїдної плівки»
- C.** «Папороті»
- D.** Дар'є-Унни
- E.** Горчакова-Арді

40. Мати скаржиться на появу у дванадцятирічної дитини сверблячого висипу на шкірі після початку відвідування школи та частого вживання шоколадних цукерок. Із анамнезу відомо, що у віці 6-11 місяців після введення прикорму в дитини виникло почервоніння шкіри обличчя та тулуба. У батька — алергічний риніт. Об'єктивно спостерігається: на шкірі розгинальної поверхні кінцівок — дисеміновані лентикулярні рожево-червоні папули на набряклій основі з везикулою, серозно-кров'янистими чи серозно-гнійними кірками на поверхні. Також виявлено ксероз шкіри гомілок, заїди, складки Дені, гіперлінеарність долонь. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Дерматит атопічний, прурігоподібна форма
- B.** Дерматит атопічний, ексудативна (екземоподібна) форма
- C.** Короста
- D.** Простий контактний дерматит
- E.** Дерматит атопічний, еритемо-сквамозна форма

41. Для подальшої динамічної оцінки призначеної терапії циклоспорином лікарю потрібно оцінити перебіг атопічного дерматиту. Який критерій враховується при обчисленні тяжкості атопічного дерматиту за шкалою SCORAD?

- A.** Оцінка ступеня ураження суглобів
- B.** Оцінка пацієнтом свого свербіжу
- C.** Оцінка асиметрії форми осередків ураження
- D.** Оцінка ультразвукових параметрів шкіри
- E.** Оцінка пацієнтом свого рівня тривоги

42. Пацієнт віком 73 роки скаржиться на періодичну появу на шкірі висипу, що останні 3 місяці не зникає, супроводжується незначним свербіжем. Із анамнезу відомо, що пацієнт довгий час лікується з приводу цукрового діабету та холециститу. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та нижніх кінцівок — вогнища ураження овальної форми у вигляді інфільтрованих пляшок червоно-ціанотичного забарвлення без чітких меж, подекуди вкритих сірувато-білими лусочками. Яке дослідження необхідно призначити пацієнту для остаточної верифікації діагнозу?

- A.** Патогістологічне дослідження висипу
- B.** Діаскопія висипу
- C.** Біохімічне дослідження крові
- D.** Мікологічне дослідження лусочок
- E.** Гратаж (пошкрібування) висипу

43. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на появу висипу на шкірі після перенесеної пневмонії, що супроводжується помірним свербіжем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок поширений висип у вигляді ізольованих лентикулярних папул рожево-червоного кольору, вкритих лусочками, під час пошкрібування папул лусочки знімаються у вигляді «облатки», по периферії зберігаються їх залишки у вигляді «комірця». Під час пошкрібування свіжих папул відзначається симптом «прихованого» лущення. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Сифіліс вторинний рецидивний
- B.** Парансоріаз краплевидний
- C.** Червоний плоский лишай
- D.** Пітиріаз рожевий (Жибер)а
- E.** Псоріаз краплевидний

44. Пацієнт скаржиться на гарячку, слабкість, задишку, біль у дрібних суглобах кистей, висип у ділянці обличчя. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 38,4°C, дифузна алопеція, еритематозний висип на щоках і спинці носа. У загальному аналізі крові: лейкоцити — $3,51 \cdot 10^9/\text{л}$, гемоглобін — 102 г/л, ШОЕ — 56 мм/год, С-реактивний білок — (++) . Рентгенологічно виявлено: ексудативний плеврит та перикардит. За результатами біопсії виявлено: гематоксилінові тільця, набухлі ядра загиблих клітин з лізованим хроматином. У загальному аналізі сечі: протеїнурія, змінені еритроцити, лейкоцити. Який найімовірніший діагноз?

- A.** Системний червоний вовчак
- B.** Себорейний дерматит
- C.** Ревматоїдний артрит
- D.** Системний васкуліт
- E.** Розацеа

45. Чоловік віком 38 років скаржиться на свербіж, печіння шкіри в ділянках міжпальцевих проміжків кистей та стоп. Об'єктивно спостерігається: ерозії, ділянки, вкриті густими нашаруваннями білого кольору з периферичним лущенням. Лікарські засоби якої групи найбільш доцільно застосувати в цьому разі?

- A.** Глюокортикоїди
- B.** Антигістамінні
- C.** —
- D.** Антибактеріальні
- E.** Антимікотики

46. У хлопчика віком 13 років батьки помітили вогнище на голові та втрату волосся. Під час огляду виявлено: загальний стан

пацієнта задовільний, на шкірі волосистої частини голови у потиличній ділянці круглий осередок правильної форми з білими лусочками, вогнище діаметром близько 3 см з обламаним волоссям на висоті 3-5 мм. Показники загального аналізу крові та сечі в нормі. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено *Microsporum lanosum*. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту?

- A. Тетрациклін
- B. Цинктерал
- C. Пеніцилін
- D. Грізеофульвін**
- E. Ретарпен

47. Який серологічний тест необхідно виконати на першому етапі обстеження, враховуючи сучасний алгоритм проведення серологічного скринінгу та підтвердження діагнозу: сифіліс?

- A. VDRL (мікрофлюкуляційний тест)**
- B. РПР (експрес тест на реакції плазми)
- C. РПГА (реакція пасивної гемаглютинації)
- D. РМП (реакція мікропреципітації)
- E. РЗК (реакція зв'язування комплекменту з ліпідним антигеном)

48. Пацієнтці віком 35 років встановлено діагноз: червоний вовчак — враховуючи наявність висипу на шкірі обличчя у вигляді еритеми з явищами фолікулярного гіперкератозу та атрофії в центрі. Консультацію яких суміжних спеціалістів має рекомендувати лікар-дерматолог при підозрі на цей діагноз?

- A. Ендокринолога, терапевта, психіатра
- B. Терапевта, гастроентеролога, онколога
- C. Терапевта, офтальмолога, ревматолога
- D. Ендокринолога, оториноларинголога, психолога
- E. Терапевта, хірурга, уролога

49. Пацієнт віком 19 років скаржиться на появу висипу на шкірі тильної поверхні кистей. Об'єктивно спостерігаються щільні папули рожевого кольору із гіперкератотичними нашаруваннями і точковими тромбованими судинами. Що з нижчезазначеного належить до неінвазивної тактики лікування цього захворювання?

- A. Крем з іміквімодом
- B. Електрокоагуляція
- C. Крем з мометазоном
- D. Кріотерапія
- E. Кюретаж**

50. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів. Із анамнезу відомо, що місяць тому мала статевий контакт без застосування бар'єрних засобів захисту. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої великої соромітної губи візуалізується щільний без-

болісний набряк ціанотично-червоного кольору, від натискування пальцем сліду на ньому не залишається. Пахвинні регіонарні лімфовузли односторонньо збільшені (з боку набряку), щільно-еластичні, безболісні, рухливі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сифіліс вторинний. Сифілітична ектима
- B. Пахова епідермофітія
- C. Еритразма
- D. Сифіліс первинний. Індуративний набряк**
- E. Генітальний герпес

51. У пацієнта віком 30 років на розгинальній поверхні кінцівок, шкірі спини спостерігається симетрична висипка вузликів яскраво-рожевого кольору розміром від сочевиці до срібної монети. Поверхня їх вкрита лусочками білого кольору. Симптом Аушпіца позитивний. На схоже захворювання в сім'ї хворіють батько та рідний брат. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вторинний сифіліс
- B. Туберкульоз шкіри
- C. Псоріаз**
- D. Червоний плоский лишай
- E. Атопічний дерматит

52. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль під час сечовипускання, виділення жовто-зеленого кольору із зовнішнього отвору уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри червоного кольору, набряклі. За результатами мікроскопії досліджуваного матеріалу, забарвленого за Грамом, у нейтрофілах виявлено розташовані попарно диплококи рожевого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гонорейний уретрит**
- B. Хламідійний уретрит
- C. Бактеріальний уретрит
- D. Трихомонадний уретрит
- E. Кандидозний уретрит

53. Пацієнт віком 32 роки, пожежник, після ліквідації пожежі скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, відчуття жару по всьому тілу. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик, температура тіла 40°C, пульс — 110/хв, дихання часте, поверхневе, м'язові посипування. Який найімовірніший діагноз?

- A. Симпато-адреналова криза
- B. Тепловий удар
- C. Отруєння чадним газом**
- D. Сонячний удар
- E. ЧМТ

54. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на виділення із піхви з неприємним запахом. Об'єктивно спостерігається: гіперемія стінок піхви, однорідні сірувато-білі виділення, тест з гідроксидом калію — позитив-

ний. За результатами мікроскопічного дослідження виділень: «ключові клітини» — 2/3 поля зору, лейкоцити — 5 у полі зору. Який збудник, найімовірніше, спричинив появу таких проявів?

- A. *Trichomonas vaginalis*
- B. *Candida albicans*
- C. *Gardnerella vaginalis*
- D. *Chlamydia trachomatis*
- E. *Neisseria gonorrhoeae*

55. Пацієнт із клінічною підозрою щодо діагнозу: саркома Капоші — категорично заперечує наявність хвороби, не визнає себе хворим, відмовляється від подальшого обстеження та лікування. До якого психологічного типу належить цей пацієнт?

- A. Сенситивного
- B. Егоцентричного
- C. Іпохондричного
- D. Гармонійного
- E. Анозогнозичного

56. Пацієнт віком 56 років скаржиться на зміни шкіри обох пахвових складок, що супроводжуються незначним свербіжем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох пахв візуалізуються гіперпігментовані плями рожево-коричневого кольору з фестончастими обрисами, чіткими межами. Усі інші ділянки шкіри та придатки — без змін. Під час огляду лампою Вуда присутня коралово-червона флюоресценція. Який збудник, найімовірніше, викликав захворювання в пацієнта?

- A. *Corynebacterium minutissimum*
- B. *Herpes simplex*
- C. *Candida albicans*
- D. *Malassezia furfur*
- E. *Trichophyton rubrum*

57. Чоловік віком 38 років, хірург за фахом, скаржиться на появу виразки на шкірі пальця, яка турбує переважно вночі у вигляді «стріляючого» болю. Об'єктивно спостерігається: дистальна фаланга вказівного пальця правої кисті набрякла, булавоподібно припухла, ціанотично-червоного кольору, в ділянці навколони́ттьового валика — глибока виразка напівмісяцевої форми з нерівними краями та дном, вкритим гнійно-некротичним нальотом. Лімфатичні вузли у правій пахвовій впадині збільшені, ущільнені, безболісні та рухомі під час пальпації, шкіра над ними без змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Стрептококова пароніхія (турніоль)
- B. Сифіліс первинний, шанкер-панарицій
- C. Хвороба Боусна, навколони́ттьова форма
- D. Туберкульозний вовчак, виразкова форма
- E. Ектима вульгарна

58. У пацієнта віком 22 роки після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Яку невідкладну допомогу необхідно надати першочергово?

- A. Вести в/в теофілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- B. Ввести в/м 0,5 мл 0,1 % розчину адреналіну (епінефрину)
- C. Виконати прийом Геймліха
- D. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта
- E. Виконати електричну дефібриляцію

59. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на печію та біль у кутах рота. В анамнезі: цукровий діабет середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: свербіж та обмеження відкриття рота, у кутах рота — рожево-червоні тріщини з білуватим нальотом. У загальному аналізі крові та сечі — нормальні показники. Глюкоза крові — 9 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Щелеподібне імпетиго
- B. Вульгарна пухирчатка
- C. Гальванічний хейліт
- D. Ангулярний кандидоз
- E. Періоральний дерматит

60. У пацієнта віком 47 років під час огляду шкіри виявлено поодинокий висип у вигляді дрібних вузликів, окремі з яких вкриті лусочками. За результатами патогістологічного дослідження елементів висипу виявлено: потовщення шипуватого шару, недостатньо сформований зернистий шар, а також потовщення рогового шару, який представлений недостатньо зроговілими пластинками зі сплосченими ядрами. Для якого типу патогістологічних змін характерні виявлені патологічні процеси у шкірі?

- A. Дискератозу
- B. Гіперкератозу
- C. Акантозу
- D. Паракератозу
- E. Гранульозу

61. Пацієнт віком 73 роки скаржиться на висипку на шкірі впродовж півроку, яка суб'єктивно не турбує, однак збільшується у розмірах. У минулому відзначав появу висипу на шкірі, яка не турбувала і самостійно вирішувалася, тому по медичну допомогу не звертався. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спини та кінцівок — невеликі вогнища з фестончастими краями, у центрі яких гіпер- та депігментовані мозаїкоподібні рубці, а по периферії — щільні напівкулясті блискучі горбики ціанотично-червоного кольору та при їх розпаді — виразки із щільними припіднятими краями. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Сифіліс третинний активний
- ☐ В. Туберкульозний вовчак, плоска форма
- ☐ С. В-лімфома, інфільтративно-бляшкова форма
- ☐ D. Хромомікоз, горбикова форма
- ☐ E. Саркоїдоз шкіри, інфільтративно-бляшкова форма

62. Трирічний хлопчик хворіє на atopічний дерматит. Через декілька днів після відвідування бабусі загальний стан дитини погіршився — піднялася температура тіла до 38,5°C, став неспокійним, відмовляється від їжі, порушився сон, з'явилися висипи, посилюється свербіж. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя та тулуба на тлі ураженої шкіри розташовуються численні згруповані везикулярні елементи з прозорим вмістом розміром 1-3 мм в діаметрі, куполоподібної форми, з пупковидним вдавленням у центрі та запальним валом по периферії. Підщелепні, передньо- і задньошийні, пахові лімфовузли збільшені, болючі під час пальпації. Інші органи і системи без патології. Яке ускладнення, імовірно, виникло в хлопчика?

- ☐ А. Бульозне імпетиго
- ☐ В. Вірусна пухирчатка
- ☐ С. Алергічний контактний дерматит
- ☒ D. Екзема Капоші
- ☐ E. Оперізувальний герпес

63. Пацієнт віком 26 років скаржиться на наявність висипань на спині й волосистій частині голови, на розгинальних поверхнях кінцівок. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та волосистої частини голови візуалізуються численні папули яскраво-червоного кольору, поверхня елементів вкрита сріблястими лусочками, подекуди папули зливаються та утворюють бляшки значних розмірів. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Мікроспорія
- ☐ В. Себорейний дерматит
- ☐ С. Плоский червоний лишай
- ☒ D. Розповсюджений псоріаз
- ☐ E. Алергічний контактний дерматит

64. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці тулуба та кінцівок, виражений свербіж шкіри. В анамнезі: хронічний тонзиліт, хронічний гастрит, коліт. Захворювання почалося раптово після укусів комарів. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізується безліч уртикарних, набряклих плям, папул розміром від шпилькової головки до зливних великих вогнищ із фестончастими краями. На окремих ділянках висип регресує. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ А. Кропив'янка
- ☐ В. Токсидермія
- ☐ С. Екзема справжня
- ☐ D. Екзема мікробна
- ☐ E. Алергічний контактний дерматит

65. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на свербіж у ділянці міжпальцевих складок кистей, передньої поверхні пахових ямок і статевих органів, що виникає переважно у вечірній час. Встановлено попередній діагноз: короста. Який метод дослідження використовують для діагностики корости?

- ☐ А. Діаскопію
- ☒ В. Метод тонких зрізів лезом
- ☐ С. Посів на поживне середовище Сабуро
- ☐ D. Гратаж
- ☐ E. Метод Дем'яновича

66. Яка форма первинної облікової документації заповнюється щодо випадків захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекції, уrogenітальний мікоплазмоз та трихомоніаз?

- ☐ А. № 090/о
- ☐ В. № 089/о
- ☐ С. № 063-2/о
- ☒ D. № 089-1/о
- ☐ E. № 089-2/о

67. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі стоп, дискомфорт у ділянці висипу, свербіж. Об'єктивно спостерігається: шкіра міжпальцевих ділянок стоп еритематозна, мацерована, дрібно лущиться, у III та VI міжпальцевих складках є поодинокі тріщини шкіри, що мокнуть. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Псоріаз
- ☐ В. Піодермія
- ☐ С. Оніходистрофія
- ☐ D. Короста
- ☒ E. Дерматофітія стопи

68. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на наявність вузлів на обох гомілкях. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох гомілок, переважно у ділянці литок візуалізуються вузли завбільшки з квасолину, щільної консистенції, трохи болісні на дотик. Шкіра над ними інтенсивно-червоного кольору з коричневим відтінком. Подскуди на гомілках відзначаються запальні плями до 5-10 мм у діаметрі, виразки відсутні. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Індуративна еритема Базена
- ☐ В. Мікробна екзема
- ☐ С. Ліпоїдний некробіоз
- ☐ D. Третинний сифіліс
- ☒ E. Вузуватата еритема

69. Який із нижченаведених діагнозів є підставою для виключення пацієнтів із військового обліку?

- A. Мікоз волосистої частини голови
- B. Піодермія дисемінована
- C. Множинні себорейні кератоми
- D. Атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву**
- E. Алергічний дерматит із дисемінованим ураженням

70. Пацієнтка віком 73 роки скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навколо трофічної виразки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці виразки шкіра червоного кольору, набрякла, місцями мокнуща, вузлики, пустули, кірочки жовтого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Стрептодермія
- B. Алергічний контактний дерматит
- C. Туберкульоз шкіри
- D. Васкуліт**
- E. Мікробна екзема

71. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на появу плями на боковій поверхні тулуба, яка суб'єктивно не турбує, однак поступово збільшується у розмірах. Із анамнезу відомо, що 1,5 місяця тому відпочивала в санаторії у лісовій місцевості. Об'єктивно спостерігається: на лівій боковій поверхні тулуба візуалізується еритема діаметром 18 см, у центральній її частині — просвітлення рожевого кольору, а по периферії — обідок темно-червоного забарвлення. Яке дослідження необхідно призначити пацієнтці для постановки діагнозу в цьому разі?

- A. Серологічне дослідження на *St. aureus*
- B. Патогістологічне дослідження висипки
- C. Серологічне дослідження на *Leishmania tropica major*
- D. Дерматоскопічне дослідження висипки**
- E. Серологічне дослідження на спірохети роду *Borrelia*

72. Пацієнтка віком 42 роки помітила припливи почервоніння обличчя під час приготування їжі та занять спортом, що супроводжуються печінням. Об'єктивно спостерігається: телеангієктазії на шкірі носа, щік, при хвилюванні, під час клінічного огляду — розлита гіперемія на обличчі. Який симптоматичний лікувальний засіб рекомендований під час цього захворювання?

- A. Крем клотримазол
- B. Гель бримонідин
- C. Гель адапален
- D. Мазь мупіроцин**
- E. Розчин кліндаміцину

73. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок. Із анамнезу відомо, що захворювання розпочалося з появи на шкірі тулуба, кінцівок та інших ділянках множинних набряклих овальних плям, спочатку їхній колір був

рожевий із фіолетовим відтінком. Діаметр плям поступово збільшувався до 1-20 см і більше, у центрі сформувалось ущільнення. В окремих місцях плями зблідли, по периферії (зона росту) зберігалось кільце фіолетового кольору. Об'єктивно спостерігається: шкіра у місці уражень кольору слонової кістки, гладенька, не збирається у складку, на поверхні немає волосся, потовиділення. Із прогресуванням захворювання бузкове кільце зникає, з'являються телеангієктазії та пігментація. З розвитком атрофії ущільнення розсмоктується, шкіра стає тонкою (вигляд «цигаркового паперу»), легко береться в складку і западає. Який найімовірніший діагноз?

- A. Трихофітія гладенької шкіри
- B. Дерматит
- C. Обмежений нейродерміт
- D. Фіксована еритема**
- E. Бляшкова склеродермія (локалізована)

74. Чоловік віком 43 роки дізнався, що лікар-дерматовенеролог, який проводив консультацію, без його дозволу надав інформацію щодо діагнозу керівнику підприємства, на якому працює чоловік. Порушення закону згідно з якою статтею Кримінального кодексу України вчинив лікар?

- A. Ст. 143
- B. —
- C. Ст. 146
- D. Ст. 154**
- E. Ст. 145

75. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на вогнище ураження на шкірі спини впродовж 2-х років, яке останнім часом почало «мокріти». Об'єктивно спостерігається: на шкірі спини візуалізується вогнище інфільтрації у вигляді бляшки з чіткими контурами овальної форми 2х4 см, застійно-червоного кольору, на поверхні якого є ерозії, поверхневі виразки, кірки, лусочки. Встановлено попередній діагноз: хвороба Боуена. Який метод діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

- A. Дослідження виділень з ерозій і виразок на піогенну флору
- B. Патогістологічне дослідження**
- C. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини
- D. Дослідження мазків-відбитків на атипові клітини
- E. Мікологічне дослідження лусочок

76. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, закладеність вух, оніміння правої кисті й утруднення рухів пальцями. Захворювання почалося гостро. Під час обстеження виявлено зниження тактильної та больової чутливості правої кисті, КСР титр 1:5. Який найімовірніший діагноз?

- A. Спинномозкова сухотка
- B. Менінговаскулярний нейросифіліс
- C. Базальний менінгіт
- D. Сифілітичний менінгомієліт**
- E. Сифілітичний неврит

77. Пацієнт віком 68 років, який хворіє на цукровий діабет та хронічний гепатит, скаржиться на появу після травми й стресу висипу на шкірі з незначним свербіжем, який триває 3 тижні. Об'єктивно спостерігається: на шкірі плеч і стегон — поодинокі лентикулярні папули, вкриті сріблястобілими лусочками, а на шкірі гомілок — поширені нумулярні папули і бляшки з чіткими межами, рожево-червоного кольору з ціанотичним відтінком, вкриті сіро-жовтими рихлими лусочко-кірками, після зняття яких видно вологу поверхню папул. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний плескатий лишай, гіпертрофічна форма
- B. Парапсоріаз хронічний, дрібнобляшкова форма
- C. Споротрихоз, поверхнева форма
- D. В-клітинна лімфома, бляшкова стадія
- E. Псоріаз дрібнобляшковий, ексудативна форма**

78. Пацієнту віком 67 років після клініко-патогістологічної діагностики осередку ураження на шкірі поса встановлено діагноз «базальноклітинний рак шкіри, поверхнева форма». Який режим використання імківімоду при базальноклітинному раку шкіри є ефективним та доказово обґрунтованим?

- A. 7 разів на тиждень протягом 6-ти тижнів
- B. 5 разів на тиждень протягом 22-ох тижнів
- C. 5 разів на тиждень протягом 6-ти тижнів
- D. 3 рази на тиждень протягом 6-ти тижнів
- E. 2 рази на тиждень протягом 1-го року

79. Пацієнт віком 38 років скаржиться на свербіж, почервоніння, набряклість і мокнуття шкіри кистей. Із анамнезу відомо, що пацієнт працює на цементному заводі. Хворіє впродовж року з періодичним поліпшенням під час відпустки. Об'єктивно спостерігається: межі ураження нечіткі, на інших ділянках шкіри висип відсутній. Який найімовірніший діагноз?

- A. Істинна екзема
- B. Професійна екзема**
- C. Хронічна виразкова піодермія
- D. Ексфоліативний дерматит
- E. Себорейна екзема

80. У п'ятирічного хлопчика діагностовано туберозний склероз (хворобу Бурневілья-Прінгля). Які зміни шкіри характерні для пацієнтів дитячого віку?

- A. Гіперпигментація у вигляді смуг
- B. «Полум'яний» невис
- C. Географічний язик
- D. Ангіофіброми обличчя
- E. Множинні базальноклітинні базаліоми

81. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість та відчуття задишки під час незначного фізичного навантаження, дискомфорт через стягування шкіри верхніх кінцівок, грудної клітки, відзначає напади побіління пальців рук, особливо у разі емоційного стресу, біль у суглобах кистей. Об'єктивно спостерігається: обличчя маскоподібне, на шкірі верхніх кінцівок індуративні осередки з ділянками атрофії, відзначається синдром Рейно, рубчики на фалангах пальців та їх деформація. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та розсіяні хрипи над легеньми, тони серця приглушені. У загальному аналізі крові: еритроцити — $3,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін — 102 г/л, ШОЕ — 24 мм/год. За результатами біохімічного аналізу крові виявлено: СРБ — (++) , фібриноген — 5,2 г/л, загальний білок — 90 г/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Червоний плоский лишай
- B. Піогенний артрит
- C. Системний червоний вовчак
- D. Системна склеродермія**
- E. Розповсюджений псоріаз

82. Пацієнт віком 14 років скаржиться на сухість шкірних покривів. Хворіє з тримісячного віку з поступовим прогресуванням клінічних проявів. Дідусь пацієнта мав аналогічні шкірні прояви. Об'єктивно спостерігається: ксероз шкіри, коричневі луски, що щільно прилягають одна до одної, тріщини. Патологічний процес вражає усю поверхню тулуба та кінцівок (включаючи згинальні та розгинальні поверхні). Долоні та підшви інтактні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бульозний епідермоліз
- B. Нейрофіброматоз
- C. Х-зчеплений рецесивний іхтіоз
- D. Вульгарний іхтіоз
- E. Долонно-підшовна кератодермія**

83. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль, печіння під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія, набряклість губок уретри, крихкий «сирний» наліт, густі білі виділення з уретри з грудками, що нагадують сир. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бактеріальний уретрит
- B. Дріжджовий уретрит
- C. Хламідійний уретрит
- D. Гонорейний уретрит
- E. Кандидозний уретрит**

84. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу висипу на червоній облямівці ни-

жньої губи. Об'єктивно спостерігається: висип у вигляді одиначної округлої ерозії кольору свіжо-розрізаного м'яса розміром 5 мм в діаметрі. Під час пальпації в її основі визначається інфільтрат. Підщеплені лімфатичні вузли збільшені з обох боків, щільно-еластичної консистенції, рухливі, неболючі. Якою повинна бути тактика лікаря для встановлення діагнозу: сифіліс?

- A. Обстежити за допомогою РІФ на сифіліс
- B. Обстежити за допомогою RW
- ☒ C. Обстежити за допомогою ІФА на сифіліс
- D. Спостерігати за станом пацієнтки
- E. Провести визначення блідой спірохети за допомогою методу темнопольної мікроскопії

85. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на появу після перенесеного грипу висипу на шкірі, що супроводжується помірним свербіжем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба й розгинальних поверхнях кінцівок відзначається поширений висип у вигляді дрібних папул рожево-червоного кольору, вкритих лусочками, які знімаються з їх поверхні у вигляді суцільної округлої луски. Для якого феномену характерний такий тип злущування?

- A. «Колоїдної плівки»
- B. «Прихованого лущення»
- C. «Облатки»
- D. «Комірця»
- E. «Стеаринової плями»

86. У чоловіка на шкірі тулуба раптово з'явився сверблячий висип у вигляді розеол, вузликів, міхурів, що розташовуються невинорядковано. Із анамнезу відомо, що висип виник після вживання в їжу креветок. Який найімовірніший діагноз?

- A. Екзема
- B. Алергічний контактний дерматит
- C. Нейродерміт
- D. Простий контактний дерматит
- ☒ E. Токсикодермія

87. У пацієнта діагностовано свіжий гонорейний і хламідійний уретрит. Які антибактеріальні лікарські засоби найефективніші в цьому разі?

- ☒ A. Цефтріаксон + азитроміцин
- B. Меропенем + хлорамфінікол
- C. Гентаміцин + ампіцилін
- D. Ванкоміцин + ципрофлоксацин
- E. Доксидиклін + метронідазол

88. У трирічної дівчинки після вживання 2-х пігулок еритроміцину виникли такі симптоми: підвищення температури тіла до 40°C, запаморочення, плями на шкірі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізуються міхури до 2-3 см у діаметрі, відшарування епідермісу з утво-

ренням великих ерозій. Симптом Нікольського позитивний. Ураження на шкірі нагадують опіки 2-го ступеня. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бульозний дерматит
- ☒ B. Синдром Лайелла
- C. Псоріаз
- D. Звичайна пухирчатка
- E. Поліморфозна ексудативна еритема

89. Що з нижченаведеного належить до клінічних проявів первинного періоду сифілісу?

- A. Лейкодерма
- ☒ B. Регіонарний лімфаденіт
- C. Горбиковий сифілід
- D. Сифілітичний гоніт
- E. Сифілітична алопеція

90. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці зовнішніх статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: у ділянці промежини та зовнішніх статевих органів візуалізуються напівкруглі папули тілесного кольору з восковим відтінком, величиною з горошину та із заглибленням у центрі (під час стискання папули виділяється біла сирниста маса). Який найімовірніший діагноз?

- A. Построкінцеві кондиломи
- B. Базаліома
- ☒ C. Контагіозний моллюск
- D. Сифіліс
- E. Червоний вовчак

91. Лікар після огляду пацієнта з ВІЛ-інфекцією встановив діагноз: генітальний герпес. З метою вибору терапевтичної тактики ознайомився із даними, опублікованими Центром із контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention). Якому принципу відповідає використання міжнародних протоколів у практиці лікаря-дерматовенеролога?

- A. Доказової медицини
- B. Коректної обробки персональних даних
- C. Академічної доброчесності
- D. Дотримання права на безкоштовну медицину
- ☒ E. Конфіденційності

92. Пацієнт віком 40 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до 38°C, появу «вузлів» на волосистій частині голови. Із анамнезу відомо, що працює скотарем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі волосистої частини голови візуалізуються осередки уражень, що різко обмежені та вкриті гнійними кірками, після зняття яких із волосяних фолікулів виділяється гній, що нагадує мед у медових стільниках. Який найімовірніший діагноз?

- А. Фавус
- В. Сифілітична алопеція
- ☒ С. Інфільтративно-гнійна трихофітія
- Д. Мікроспорія
- Е. Карбункул

93. Жінка віком 20 років на прийомі у лікаря-дерматовенеролога поводить себе ментушливо, неспокійно, хоче впевнитися, що про факт звернення по медичну допомогу та встановлений діагноз не дізнаються її батьки. Лікар заспокоїв пацієнтку, наголосивши, що згідно зі статтею Цивільного кодексу вона має право на таємницю про стан свого здоров'я. Яка це стаття?

- А. Ст. 230
- В. Ст. 289
- С. Ст. 268
- Д. Ст. 286
- Е. —

94. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на пінисті виділення з уретри, свербіж зовнішніх статевих органів. За результатами кольпоскопічного дослідження виявлено: на слизовій оболонці піхви точкові крововиливи. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гонорея
- В. Мікоплазмоз
- С. Трихомоніаз
- Д. Кандидоз
- Е. Хламідіоз

95. Яка шкала дозволяє встановити стадію та тяжкість адреногенетичної алопеції у жінок?

- А. Norwood
- В. Norwood-Hamilton
- С. Hamilton
- Д. Ludwig
- ☒ Е. Фіцпатрика

96. Під час огляду пацієнта віком 15 років навколо носа та щік виявлено множинні ангіофіброми, на тулубі спостерігаються плями, що нагадують «ясеневе листя». З анамнезу відомо про періодичні судомні напади із втратою свідомості. Із дворічного віку затримка первово-психічного розвитку. Яке захворювання характеризується асоціацією епілепсії, розумової відсталості та вищенаведених шкірних проявів?

- А. Долонно-підшовна кератодермія
- В. Іхтіоз вульгарний
- С. Туберозний склероз
- ☒ Д. Бульозний епідермоліз
- Е. Синдром стафілококової обпеченої шкіри

97. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та болючий висип на бічній поверхні грудної клітки ліворуч. Вказані симптоми з'явилися після перенесеного стресу. Об'єктивно спостерігається: на бічній по-

верхній тулуба множинні міхурці, заповнені серозно-геморагічним вмістом. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ А. Простий герпес
- В. Алергічний дерматит
- С. Стрептодермія
- Д. Везикулопустульоз
- Е. Оперізуючий герпес

98. Лікар-дерматолог у зв'язку із виробничою необхідністю зайняти посаду завідувача відділення має отримати підвищення кваліфікаційного рівня. Яка вимога повинна бути обов'язково дотримана для отримання лікарем-дерматовенерологом вищої кваліфікаційної категорії?

- А. Спеціалізація за фахом «Клінічна імунологія»
- В. Наявність двох закордонних стажувань
- С. Участь у трьох професійних об'єднаннях/асоціаціях
- ☒ Д. Стаж роботи за фахом до 5 років
- Е. Стаж роботи за фахом понад 10 років

99. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на виділення із піхви, що супроводжувались рибним запахом. За результатами мікроскопічної діагностики виділень виявлено: наявність «ключових клітин» у всьому полі зору. Який із нижченаведених лікарських засобів є препаратом першої лінії в лікуванні цього стану?

- А. Офлоксацин
- В. Метронідазол
- С. Цефтріаксон
- Д. Пеніцилін
- Е. Доксициклін

100. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу висипу на обличчі. Об'єктивно спостерігається: у ділянці обличчя візуалізуються численні асимітомні плоскі, тілесного кольору папули. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х років. Який найімовірніший діагноз?

- А. Розацеа
- В. Сикоз
- ☒ С. Бородавки плоскі
- Д. Акне
- Е. Бородавки вульгарні

101. Пацієнт віком 13 років скаржиться на безболісне збільшення статевого члена. З анамнезу відомо, що місяць тому був оральний секс із незнайомою дівчиною. Об'єктивно спостерігається: статевий член значно збільшений, ціанотично-червоного кольору, ущільнений під час пальпації, ямка при натискуванні на його поверхню не утворюється. Пахові лімфатичні вузли збільшені, ущільнені, безболісні та рухомі під час пальпації, шкіра над ними без ознак запалення. Серореакції на сифіліс негативні. Який метод діагностики необхідно за-

стосувати першочергово для уточнення діагнозу?

- A. Бактеріологічне дослідження слизової уретри на хламідії
- B. Бактеріологічне дослідження слизової уретри на піогенну флору
- C. Мікроскопічне дослідження пунктату статевого члена на білду спірохету**
- D. Обстеження на туберкульозну інфекцію
- E. Дослідження пунктату статевого пруття на атипові клітини

102. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначні серозно-гнійні виділення з уретри, переважно зранку до сечовипускання та біль під час сечовипускання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 8-ми діб. Об'єктивно спостерігається: незначна набряклість і почервоніння губок уретри. За результатами бактеріоскопічного дослідження зішкрібів з уретри виявлено тільки Гальберштедтера-Провачека. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний гонорейний уретрит
- B. Гострий гонорейний уретрит
- C. Бактеріальний уретрит
- D. Трихомонадний уретрит**
- E. Гострий хламідійний уретрит

103. Пацієнт віком 25 років скаржиться на рясні водянисті виділення з уретри, незначний дискомфорт в уретрі зранку. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому був статевий акт без застосування бар'єрних засобів контрацепції. Об'єктивно спостерігається: губки уретри незначно гіперемовані та набряклі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Генітальний герпес
- B. Хламідіоз
- C. Трихомоніаз
- D. Гонорея**
- E. Мікоплазмоз

104. У пацієнтки віком 62 роки в ділянці носогубної складки протягом останніх 1,5-2 років з'явилося новоутворення діаметром 6-7 мм з дерматоскопічними ознаками базально-клітинного раку шкіри. Яка подальша тактика ведення пацієнтки?

- A. Лікування топічним імквімодом
- B. Проведення променевої терапії
- C. Проведення діагностичної біопсії**
- D. Термінове лікування в онколога
- E. Видалення новоутворення шляхом електрокоагуляції

105. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу плям білого кольору. Об'єктивно спостерігається: на засмаглій шкірі тулуба та кінцівок візуалізуються множинні ділянки гіпопигментації, під час пошкрябування виникає муковидне злущення. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лейкодерма
- B. Висівкоподібний лишай (різнокольоровий)**
- C. Вітиліго
- D. Токсикодермія
- E. Склеродермія

106. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на свербіж та випадіння волосся. Об'єктивно на волосистій ділянці голови виявлено: візуалізується кільцеподібна пляма червоно-рожевого кольору розміром до 5 см, волосся в місці ураження обламане на одному рівні — вище від поверхні шкіри на 3-6 мм, шкіра гіперемована, вкрита сіруватими дрібними лусочками. Встановлено попередній діагноз: мікроспорія. Який метод дослідження використовують для діагностики мікроспорії?

- A. Посів на поживне середовище Плоскірева
- B. Посів на поживне середовище Сабуро
- C. Реакцію Вассермана
- D. Пробу з розчином срібла**
- E. Діаскопію

107. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на виникнення на шкірі кінцівок помірно сверблячого висипу через тиждень після перенесеного гострого тонзиліту. З дитинства хворіє на хронічний тонзиліт. Об'єктивно спостерігається: на шкірі розгнальної поверхні кінцівок розташовані округлі та овальні вогнища монетовидних розмірів із чіткими межами. Шкіра у вогнищах з проявами гіперемії та інфільтрації, на поверхні — міліарні папули, мікроескудики, подекуди — мікроерозії, серозні й серозно-гнійні кірочки, лусочки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматомікоз багатовогнищевий
- B. Екзема нумулярна
- C. Екзема істинна**
- D. Екзема себорейна
- E. Еритема ексудативна багатформна

108. Пацієнт віком 32 роки, пастух, скаржиться на появу у паху болючих «ущільнень» упродовж двох тижнів. Об'єктивно спостерігається: у правій паховій ділянці визначаються декілька щільних вузлів діаметром 1-1,5 см, під час пальпації вузли болючі, окремі — з проявами флуктуації, шкіра над вузлами гіперемована, у ділянці найбільшого вузла — нориця з гнійним виділенням. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульоз шкіри, коліквативна форма
- B. Трихофітія, інфільтративно-нагнійна форма
- C. Лейшманіоз шкіри, сільський тип
- D. Гідраденіт пахової ділянки**
- E. Множинні фурункули пахової ділянки

109. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла,

біль у суглобах та м'язах, появу висипу на шкірі. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 5-ий день після прийому антибіотиків у зв'язку із застудою. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, температура тіла — 39°C , на шкірі розгинальних поверхонь передпліч, тильної сторони кистей, гомілок та стоп — множинний плямисто-папульозний висип, міхурі. За результатами аналізу крові виявлено: лейкоцитоз, лімфопенія, еозінопенія, збільшення ШОЕ. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цьому разі?

- A. Вульгарної пухирчатки, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- B. Синдрому Лайелла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- C. Герпетичного дерматозу Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- ☒ D. Синдрому Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- E. Оперізуючого герпесу, визначити ступінь ураження та призначити лікування

110. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на сверблячий висип на шкірі гомілок впродовж 5-ти місяців. Із анамнезу відомо, що після самолікування спиртовими розчинами стан на шкірі погіршився, курить, хворіє на хронічний гепатит. Об'єктивно спостерігається: на шкірі передньої та бокових поверхонь гомілок — округлі чи з нерівними краями припідняті червоно-ціанотичні та буруваті бляшки з гіперкератотичною бородавчастою поверхнею. По периферії бляшок — дисеміновані лентикулярні плоскі полігональні червоно-фіолетові блискучі папули з точковим заглибленням у центрі, подекуди — екскоріації. Який найімовірніший діагноз?

- A. Туберкульоз шкіри бородавчастий
- B. Т-лімфома, інфільтративно-бляшкова форма
- ☒ C. Червоний плоский лишай, верукозна форма
- D. Хромомікоз
- E. Пруріго дорослих хронічне

111. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на ураження шкіри кистей і нижньої третини передпліч. Об'єктивно спостерігається: на фоні гіперемії та інфільтрації візуалізується поліморфний висип у вигляді везикул, ерозій, тріщин і кірок. Який найімовірніший діагноз?

- ☒ A. Атопічний дерматит
- B. Вітряна віспа
- C. Хвороба Рейно
- D. Хвороба Коксаки
- E. Справжня екзема

112. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу виразки, що розташована на статевому члені. Об'єктивно спостерігається:

на статевому члені візуалізується виразка круглої форми з чіткими краями, пахові лімфатичні вузли збільшені, не болючі, рухливі. На шкірі тулуба виявлено дрібні рожеві плями, що не зливаються, не лущаться. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первинний сифіліс
- B. Шанкриформна піодермія
- C. Коростяна ектима
- ☒ D. Вторинний сифіліс
- E. Епітеліома

113. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на ураження шкіри правої гомілки та свербіж. Із анамнезу відомо, що пацієнтка 3 тижні тому травмувала праву гомілку, після чого на шкірі з'явилася рана, яка не загоювалася. Об'єктивно спостерігається: вогнище ураження має чіткі межі, вздовж краю якого наявне відшарування епідермісу, у центрі вогнища на фоні еритеми з ціанотичним відтінком і набряку визначаються мокнучі ерозії, серозно-гнійні кірки, позитивний симптом «серозно-колодязі». Який найімовірніший діагноз?

- A. Істинна екзема
- ☒ B. Паратравматична екзема
- C. Професійна екзема
- D. Себорейна екзема
- E. Піодермія

114. Який метод використовують для патоморфологічного дослідження пухирних уражень шкіри?

- A. Дермографізм
- ☒ B. Визначення симптому Нікольського
- C. Діаскопію
- D. Шкірні проби
- E. Пробу Томпсона

115. У пацієнтки віком 14 років на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються еритеми, папули, екскоріації. Шкіра суха, наявний білий дермографізм. Загострення виникають після стресу. За результатами дослідження крові виявлено: підвищений вміст імуноглобуліну E. Який найімовірніший діагноз?

- A. Екзема
- B. Кропив'янка
- C. Алергічний контактний дерматит
- ☒ D. Атопічний дерматит
- E. Пітіріаз рожевий (Жибера)

116. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на безболісне збільшення однієї соромітної губи. З анамнезу відомо, що місяць тому мала випадковий статевий контакт, три тижні тому — переохолодження на катку. Об'єктивно спостерігається: права соромітна губа значно збільшена, ціанотично-червоного кольору, ущільнена під час пальпації, ямка при натискуванні на поверхню

губи не утворюється. Пахові лімфатичні вузли помірно збільшені, ущільнені, безболісні та рухомі під час пальпації, шкіра над ними без змін. Серореакції на сифіліс негативні. Який метод діагностики необхідно застосувати першочергово для уточнення діагнозу?

- A. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на хламідії
- B. Обстеження на туберкульозну інфекцію
- C. Патогістологічне дослідження біоптату соромітної губи
- D. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на піогенну флору
- ☒ E. Мікроскопічне дослідження пунктату соромітної губи на бліду спірохету

117. Пацієнт віком 16 років звернувся зі скаргами на множинні закриті та відкриті комедони на шкірі обличчя. Яких правил має дотримуватися пацієнт при призначенні топічного адапалену?

- A. Приймати паралельно системні пробіотики
- ☒ B. Не перебувати довго на відкритому повітрі без використання сонцезахисних засобів
- C. Уникати публічних місць, використовувати респіраторну маску
- D. Не контактувати з водою
- E. Приймати антигістамінні засоби у двократному дозуванні

118. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на наявність сосочкоподібних розростань у ділянці зовнішніх статевих органів. Встановлено попередній діагноз: гострокінцеві кондиломи. Яка найімовірніша причина цієї патології?

- A. Мікоплазми
- B. Сифіліс
- C. Вірус простого герпесу
- D. Хламідії
- ☒ E. Вірус папіломи людини

119. У дитини віком 12 років діагностовано дерматит атопічний, ліхеноїдну форму. Після проведеного лікування вогнища ліхеніфікації на шкірі ліктьових і підколінних складок регресували. Який із лікарських засобів необхідно призначити дитині на ці ділянки шкіри у період клінічної ремісії для профілактики загострень атопічного дерматиту?

- A. Крем із мометазоном 0,1%
- B. Мазь метилпреднізолону ацепонат 0,1%
- C. Крем із клобетазолом пропіонатом 0,05%
- D. Мазь такролімусу 0,1%
- ☒ E. Мазь такролімусу 0,03%

120. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на появу плям темного кольору на обличчі та шиї, що поступово збільшуються та

темнішають. Із анамнезу відомо, що хворіє близько 2-х років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя та шиї візуалізуються дві темні плями з нерівним контуром до 5 см в діаметрі, із лущенням на поверхні. Яке дослідження потрібно провести пацієнту?

- A. Імунологічне
- B. Культуральне
- C. Трихологічне
- D. Мікроскопічне
- ☒ E. Дерматоскопічне

121. Пацієнт скаржиться на появу висипу, біль та печіння у ділянці обох кистей. Виникнення хвороби пов'язує з контактом із формальдегідною смолою. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох кистей візуалізуються еритеми, що мають чіткі межі, везикули, поодинокі міхури. Який найімовірніший діагноз?

- A. Токсикодермія
- B. Алергічний контактний дерматит
- C. Пітиріаз рожевий (Жибера)
- D. Простий контактний дерматит
- ☒ E. Справжня екзема

122. Пацієнта віком 43 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: токсикодермія. Під час перебування в стаціонарі пацієнт ігнорує факт тяжкості захворювання, вважає, що в такому стані може продовжувати працювати. Укажіть яку позицію відносин лікаря та пацієнта потрібно використати з таким пацієнтом у контексті деонтологічного підходу.

- A. Інформаційну — безпристрасний лікар та автономний пацієнт
- B. Колегіальну — рівноправ'я та взаємна довіра
- C. Ліберальну — активна позиція пацієнта
- D. Патерналістську — лікар-опікун, наставник та підопічний
- ☒ E. Інтерпретаційну — переконливий лікар, тривале спілкування лікаря з пацієнтом

123. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на свербіж, біль і появу висипу у ділянці головки статевого члена. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно спостерігається: на голові статевого члена та внутрішньому листку крайньої плоті візуалізуються плямисто-папульозний висип, білі бляшки, пустули, ерозії, набряк, тріщини крайньої плоті. Який найімовірніший діагноз?

- A. Контагіозний моллюск
- B. Первинний сифіліс
- ☒ C. Кандидозний баланопостит
- D. Простий герпес
- E. Пріапизм

124. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу сверблячих висипань на шкірі. Із анамнезу відомо, що висип з'явився 2 тижні

тому після проживання в тимчасовому гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб та контакту з тваринами. Об'єктивно спостерігається: на шкірі живота, міжпальцевих проміжків — папуло-везикулярні елементи, сліди розчухувань, кірочки. Який оптимальний план діагностики для пацієнтки?

- ☐ А. Проведення мікроскопічного дослідження на коростяний кліщ
- ☐ В. Виконання алергених проб для визначення можливих причин алергічної реакції
- ☐ С. Проведення бактеріологічного дослідження висипань для виявлення патогенних мікроорганізмів
- ☐ Д. Консультація з ветеринарним лікарем для вивчення можливого впливу домашніх тварин на здоров'я пацієнта
- ☐ Е. Виконання експрес-тесту на алергічну реакцію до будь-яких домашніх тварин

125. У жінки віком 30 років діагностовано синдром Фітца-Х'ю-Куртіса. Які мікроорганізми спричиняють цей синдром?

- ☐ А. Стафілококи
- ☐ В. Хламідії
- ☐ С. Мікоплазми
- ☐ Д. Гарднерели
- ☐ Е. Трихомонади

126. У пацієнтки віком 30 років під час огляду виявлено: на волосистій частині голови візуалізуються два нумулярних вогнища облісіння, діаметром 4 та 3,5 см. Позитивний тест натягнення волосся. Під час трихоскопії спостерігається: чорні крапки, обламане волосся, волосся у формі знака оклику. Встановлено діагноз: гніздова алопеція. Яка тактика лікування пацієнта (І лінія терапії)?

- ☐ А. Топічні кортикостероїди
- ☐ В. Системні кортикостероїди
- ☐ С. Системні імуносупресанти
- ☐ Д. JAK-інгібітори
- ☐ Е. Топічний міноксидил

127. Жінка віком 20 років скаржиться на болючість та печіння під час сечовипускання, що турбують її протягом чотирьох днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри гіперемовані, набряклі, із зовнішнього отвору виділяються краплі гною. Які додаткові методи дослідження потрібно провести для встановлення діагнозу?

- ☐ А. Серологічний метод
- ☐ В. Загальний аналіз крові
- ☐ С. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження
- ☐ Д. Клінічний аналіз сечі
- ☐ Е. ІФА

128. Під час гістологічного дослідження біоптату шкіри жінки віком 30 років лікар спостерігає: плоскі клітини, які не мають

ядер, розташовані у два ряди, їх протоплазма містить білок елеїдин. Для якого шару шкіри характерна така гістологічна картина?

- ☐ А. Зернистого
- ☐ В. Рогового
- ☐ С. Шипуватого
- ☐ Д. —
- ☒ Е. Блискучого

129. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття та появу впродовж останніх 3-х місяців помірно болючого висипу на шкірі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт астенічної статури, на шкірі верхньої половини тулуба, статевому члені та твердому піднебінні візуалізуються дисеміновані соковито-вишневого кольору лентикулярні вузлики з гладенькою поверхнею, а також гіперпігментні плями діаметром 1,5–2 см фіолетового та ціанотично-чорного кольору. За результатами загального аналізу крові виявлено лімфопенію. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Множинні невуси
- ☐ В. Різнокольоровий лишай
- ☐ С. Сифіліс вторинний
- ☐ Д. Червоний плоский лишай
- ☒ Е. Саркома Капоші

130. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип шкіри обличчя та незначний дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х років, висип повільно прогресує. Відзначає, що скарги посилюються у спеку та під час відвідування лазні. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спинки носа з переходом на обидві щіки візуалізується суцільна інфільтрована червона пляма у формі метелика з ціанотичним відтінком, що місцями вкрита білуватими дрібними лусочками. Під час пошкрябування лусочок пацієнт відчуває помірний біль. У центрі ураження шкіри по обидва боки від носа відзначаються невеликі островці рубцевої атрофії, оточені зоною гіперкератозу. Скарг із боку інших органів та систем немає. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Розацеа
- ☐ В. Демодикоз
- ☐ С. Акне
- ☐ Д. Системний червоний вовчак
- ☒ Е. Дискоїдний червоний вовчак

131. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль під час сечовипускання та виділеннями з уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри гіперемовані, набряклі, наявні гнійні виділення. Під час проведення двосклянкової проби в першій порції сеча дифузно-каламутна. За результатами бактеріоскопічного дослідження в мазку ви-

явлено підвищену кількість лейкоцитів до 100 в полі зору, розміщені диплококи. Який найімовірніший діагноз?

- A. Асимптомний гонорейний уретрит
- B. Гострий тотальний гонорейний уретрит
- C. Гострий передній гонорейний уретрит
- D. Торпідний гонорейний уретрит
- E. Хронічний гонорейний уретрит

132. Пацієнтка віком 22 роки мала одноразовий статевий контакт без застосування бар'єрних засобів контрацепції з хлопцем, у якого нещодавно було виявлено вторинний свіжий сифіліс. Під час огляду шкіри та досяжних для огляду слизових оболонок висипів не знайдено. Якою повинна бути тактика лікаря-дерматовенеролога у цій ситуації?

- A. Провести превентивне лікування сифілітичної інфекції
- B. Спостерігати за станом пацієнтки
- C. Проконсультувати у сімейного лікаря
- D. Проконсультувати у лікаря-гінеколога
- E. Провести серологічне обстеження на сифіліс

133. Пацієнт віком 38 років понад п'ять років тому лікував вторинний рецидивуючий сифіліс, лікування не закінчив, змінив місце проживання. Об'єктивно спостерігається: на шкірі чола та носа наявний висип у вигляді горбиків. Реакції РІБТ, РІФ позитивні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Третинний сифіліс
- B. Вузливатий васкуліт
- C. Туберкульозний вовчак
- D. Вторинний сифіліс
- E. Туберкульоз шкіри

134. Пацієнтці віком 57 років клініко-гістологічно встановлено діагноз: вульгарна пухирчатка — призначено преднізолон у дозі 1 мг/кг маси тіла. Які побічні ефекти від тривалого приймання системних глюкокортикостероїдів можна очікувати в цьому разі?

- A. Остеонекроз голівки стегнової кістки, гіперпротеїнемія
- B. Збільшення маси тіла, акне, гіперкальціємія
- C. Синдром Кушинга, зміна кольору нігтьових пластин, ортостатична гіпотензія
- D. Гіперкаліємія, виразка шлунка, порушення сну
- E. Гіпертензія, остеопороз, цукровий діабет

135. Пацієнт віком 50 років для лікування розповсюдженого бляшкового псоріазу самостійно використовував 20% саліцилову мазь, що спровокувало прогресування процесу аж до еритродермії. Який лікарський засіб системної терапії потрібно призначити пацієнту в цьому разі?

- A. Метотрексат
- B. Дапсон
- C. Пеніцилін
- D. Хлорохін
- E. Дексаметазон

136. Під час реєстрації професійних захворювань шкіри лікар-дерматолог діє згідно з Інструкцією про порядок діагностики та реєстрації професійних захворювань шкіри. Який Наказ регламентує діяльність лікаря в цьому разі?

- A. № 203
- B. № 207
- C. —
- D. № 209
- E. № 301

137. У пацієнтки віком 22 роки під час огляду виявлено: на шкірі лівого крила носа з переходом на шкіру щоки спостерігається вогнище ураження, на еритематозному тлі є горбки розміром з дрібну горошину, коричнево-рожевого кольору, м'якої тістоподібної консистенції з гладенькою, трохи блискучою поверхнею. Висип зрідка вкритий лусочками. Із анамнезу відомо, що хворіє з десятирічного віку. Який найімовірніший діагноз?

- A. Себорейний дерматит
- B. Червоні (рожеві) вугрі, демодекоз
- C. Вугрова хвороба
- D. Червоний вовчак
- E. Туберкульозний (вульгарний) вовчак

138. Мати скаржиться на появу у чотирирічної дитини сверблячого висипу на шкірі, який виник після гостювання у бабусі, де вживала полуницю та гралася з кішкою в садку на траві. Із анамнезу відомо, що у віці 7-9 місяців після прикорму у дитини виникло почервоніння і набряк шкіри обличчя та сідниць. Бабуся дівчинки хворіє на бронхіальну астму. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба і згинальних поверхні кінцівок — еритематозні вогнища округлої та овальної форми без чітких меж, на поверхні — незначне лущення, ескоріації. Також виявлено помірний ксероз шкіри, заїди, потемніння шкіри навколо очей, тріщини за вухами. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дерматит атопічний, ліхеноїдна форма
- B. Мікроспорія гладкої шкіри
- C. Дерматит атопічний, еритемо-сквамозна форма
- D. Дерматит контактний простий (фітодерматит)
- E. Дерматит контактний алергічний

139. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на запалення слизових оболонок очей, порожнини рота, носа та статевих органів, появу висипу на шкірі, підвищення температури тіла, слабкість. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли після введення про-

типравцевої сироватки 3 дні тому. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, температура тіла — 41°C , свідомість сплутана, на всій шкірі візуалізуються еритематозні плями з коричневим відтінком, в'ялі міхури, яскраво-червоні зливні ерозії. Виявлено болючість шкіри, під час дотику епідерміс зморщується, на кистях та стопах — відшарування епідермісу у вигляді «рукавичок та шкарпеток». Симптом Нікольського різко позитивний. На слизових оболонках поодинокі яскраво-червоні ерозії. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цій ситуації?

- ☐ А. Синдрому Лайелла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- ☐ В. Фіксованої токсикодермії, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- ☐ С. Герпетичного дерматозу Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- ☐ Д. Синдрому Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- ☐ Е. Вульгарної пухирчатки, визначити ступінь ураження та призначити лікування

140. Жінка віком 25 років на 5-й день після незахищеного статевого акту скаржиться на свербіж, печіння в уретрі, виділення з піхви зеленувато-жовтого кольору, часті позиви до сечовипускання, яке є болючим, в сечі домішки крові. За результатами мікроскопії мазку виділень виявлено: грамнегативні диплококи у вигляді кавових зерен. Який збудник викликав захворювання в пацієнтки?

- ☐ А. *Trichomonas vaginalis*
- ☐ В. *Mycoplasma*
- ☐ С. *Neisseria gonorrhoeae*
- ☐ Д. *Candida albicans*
- ☐ Е. *Chlamydia trachomatis*

141. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задишки, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ — 110/60 мм рт. ст., ЧСС — 40/хв. Який антидот необхідно застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

- ☐ А. Гідрокарбонат натрію
- ☐ В. Атропін
- ☐ С. Унітіол
- ☐ Д. Налоксон
- ☐ Е. Гіпербарична оксигенація

142. Жінка віком 33 роки скаржиться на інтенсивний нестерпний свербіж шкіри в ділянці лобка. Захворювання пов'язує з носінням чужої білизни. Об'єктивно на шкірі нижньої частини живота, лобка та вну-

трішніх поверхонь стегон спостерігаються множинні сліди розчухів і геморагії. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Педикульоз
- ☐ В. Короста
- ☐ С. Дерматит
- ☐ Д. Екзема
- ☒ Е. Контагіозний моллюск

143. Мати скаржиться, що у дитини на 6-й день після народження підвищилася температура тіла і з'явився висип на шкірі. Об'єктивно спостерігається: загальний стан дитини тяжкий, температура тіла — 39°C , на шкірі тулуба в навколонульовій зоні з поширенням на живіт, а також на сідницях, стегнах, у великих складках — численний висип у вигляді плоских бульозних елементів із тонкою покрішкою та серозно-гнійним вмістом та ерозії яскраво-червоного кольору із серозно-гнійним виділенням, які мають тенденцію до поширення. Шкіра навколо висипу різко гіперемована, набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- ☐ А. Пухирчатка епідемічна немовлят
- ☐ В. Імпетиги контагіозне
- ☐ С. Попрілість
- ☐ Д. Кандидоз складок
- ☒ Е. Вроджений бульозний епідермоліз

144. Пацієнтка віком 34 роки, яка постійно використовує лаки для нігтів, скаржиться на зміну структури нігтів пальців рук. Об'єктивно спостерігається: нігтьові пластинки пальців рук потоніли (у вигляді ячної шкаралупи) із розм'якшенням по вільному краю, схильністю до обламування та утворення тріщин. Для якого типу оніходистрофії характерні виявлені у пацієнтки зміни нігтів?

- ☐ А. Оніхошизис
- ☐ В. Оніхорексис
- ☐ С. Койлоніхія
- ☐ Д. Гапалоніхія
- ☒ Е. Оніхолізіс

145. Пацієнт віком 15 років скаржиться на появу висипу в ділянці стопи, що супроводжується больовими відчуттями під час ходьби. Елемент виник 5 місяців тому після відвідування басейну. Об'єктивно спостерігається: на шкірі підошовної поверхні лівої стопи гіперкератотична папула жовтого кольору з чіткими межами 0,5 см в діаметрі. Дерматоскопічно: верукозна поверхня, точкові тромбовані капіляри. Для якого захворювання характерна така клініко-дерматоскопічна картина?

- А. Псоріазу
- В. Вторинного сифілісу
- С. Червоного плоского лишая
- Д. Підлошовної бородавки**
- Е. Контагіозного моллюску

146. Пацієнт віком 25 років скаржиться на появу висипу в ділянці головки статевого члена. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена візуалізується безболісна виразка розміром до 1,5 см у діаметрі без вогнищево-запальних змін, правильної округлої форми, з чіткими межами, піднесена над навколишніми здоровими тканинами. Дно виразки гладке, блискуче, яскраво-червоного кольору, краї пологі (блюдоподібні), незначна серозна ексудація, в основі — «хрящеподібний» щільно-еластичний інфільтрат, пахові лімфатичні вузли збільшені з обох боків, близько 1 см у діаметрі. Який найімовірніший діагноз?

- А. Третинний сифіліс
- В. Шанкріформна піддермія
- С. Вторинний сифіліс
- Д. Первинний сифіліс**
- Е. Простий герпес

147. У пацієнта віком 78 років діагностовано: сифіліс третинний активний. Об'єктивно спостерігається: на шкірі сідниць і нижніх кінцівок розташовані вогнища ураження із горбиків на різних стадіях розвитку — у центрі вогнищ у ділянці регресу горбиків формуються «мозаїкоподібні» рубці, а по периферії вогнищ — утворення свіжих горбиків, які мають тенденцію до поширення із «змінюваними» хвилястими краями. Для якої форми (типу) вогнищ характерне таке розташування елементів висипу?

- А. Великофестончастої**
- В. Полігональної
- С. Гроноподібної
- Д. Серпігінуючої
- Е. Згрупованої

148. Мати скаржиться на появу у восьмирічного хлопчика вогнища нагноєння та облісіння на волосній ділянці голови через 3 тижні після поїздки в село до бабусі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі волосної частини голови — два гострозапальні інфільтрати у вигляді вузлів, що підвищу-

ються над поверхнею шкіри, на їх поверхні — фолікулярні пустули з гнійним виділенням та гнійними кірками, волосся на поверхні вузлів легко видаляється разом з гнійним виділенням. Позитивний симптом «медових стільників». Яке дослідження необхідно застосувати першочергово для уточнення діагнозу?

- А. Загальний аналіз крові
- В. Люмінесцентна діагностика волосся із застосуванням лампи Вуда
- С. Бактеріологічне дослідження гнійного виділення
- Д. Аналіз крові на рівень глюкози
- Е. Мікологічне дослідження волосся та гнійного виділення**

149. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на висип у ділянці бороди та вусів, що супроводжується почуттям печії, свербіжу, поколювання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 1-го місяця, спочатку на підборідді з'явилися окремі пустули з гнійним вмістом, які підсихали з утворенням кірок. На момент огляду процес локалізується на шкірі підборіддя та носогубного трикутника. Шкіра під час пальпації щільна, інфільтрована, ціанотично-червоного кольору. Об'єктивно спостерігається: у ділянці ураження — велика кількість пустульозних елементів, багато з яких пронизані волоссям, множинні брудно-жовті кірки. Який найімовірніший діагноз?

- А. Сикоз стафілококовий**
- В. Мікроспорія
- С. Мікробна екзема
- Д. Герпетична інфекція
- Е. Імпетиги вульгарне

150. Дівчина віком 18 років скаржиться на появу папул, пустул на шкірі обличчя, які, за її словами, псувають її зовнішній вигляд. Об'єктивно спостерігається: на шкірі лоба, щік і підборіддя є папули та пустули, $d=3-5$ мм. Більшість пустул з видимим центральним стрижнем із гною. Який найімовірніший діагноз?

- А. Алергічний дерматит
- В. —
- С. Акне
- Д. Фолікулярний кератоз**
- Е. Розацеа